

INFECTIEUX

Dr.KHERBA_N

INFECTIEUX

Accident d'exposition au sang

Brucellose

Coqueluche

Diphtérie

Fièvre boutonneuse FBM

Leptospirose

Mononucléose infectieuse MNI

Morsure d'un animal

Morsure du serpent

Morsure humaine

Oreillons

Piqûre d'araignée

Piqûre de Meduse

Piqûre de mille pattes

Piqûre de Tique

Rongeurs

Rougeole

Rubéole

Sueurs nocturnes

Syphilis

Tétanos

Toxoplasmose

Tuberculose

Varicelle

Viroses

Zona

Accident d'exposition au sang

- Soins d'urgence : laver au savon pdt au (-) 5min puis désinfecter par un antiseptique alcool, Dakin..
 - Connaître le statut vaccinal/évaluer le risque infectieux
 - Selon le type d'AES : calibre d'aiguille, aiguille creusée ou pleine, profondeur de blessure..
 - Faire les sérologies pour la source/victime :
 - 1 HVB=> victime
 - Si correctement vacciné + titrage >10U=> Rien
 - Si non vacciné + titrage <10U=> Demande une sérologie de la source
- (si (-)= Rien /si (+)=> Demander une sérologie HVB pour victime (J1-8 M1M3M6) + ALAT/ALAT..

+ Traitement post exposition par Ig et Vaccin contre HVB

2 HVC tout dépend de la source :

- Si séro (-) => Rien
- Si séro (+) => Demander une séro HVC (même schéma que pour HVB) + ALAT/ALAT
- Pas de Traitement post exposition

3 VIH selon la source :

- Si séro (-) => Rien
- Si séro (+) => Demande une séro VIH

+ Traitement post exposition par Arv pdt 1 mois

→ Déclaration de l'accident du travail

Brucellose

● Clinique :

- Triade : fièvre ondulante, douleurs diffuses, sueurs nocturnes à odeur de paille pourrie..
- Ostéo_articulaire et neurologique puis les autres localisations..
- Consommation de produits laitiers non pasteurisés
- BEG
- Examen : SPM, HPM, ADP
- FNS : leucopénies < 6000
- CRP/VS ↗
- Transaminases ↗ 2×N
- Hémoculture (Pic fébrile)
- Sérologie de Wright

→ Orientation infectieux

✓ CAT :

- Déclaration obligatoire
- Traitement : en fonction des stades et formes cliniques
- Doxycycline (CI chez la femme enceinte et enfants <8ans)
- Gentamycine
- Aminosides
- Rifamycine 300 3cp le matin à jeun

- Doxycycline : Dotur 200mg/j cp 100mg 1cp 2/j ou 200mg 1cp/j pdt 6sem 42j le soir
- Gentamycine 3mg/kg/j 80mg inj pdt 14j
- Rénal/Hépatique avant puis chaque 7j
- Surveillance clinique après 1 et 3mois

■ Enfant 🧒 : <8ans

Aminoside + Rifamycine

Ou Amoxicilline + Rifamycine

Ou Bactrim + Gentamycine

Coqueluche

● Clinique :

Infection respiratoire bactérienne peu ou pas fébrile de l'arbre respiratoire supérieur, mais d'évolution longue et hautement contagieuse

Toux en quintes, difficultés respiratoires et parfois de vomissements..

✓ CAT :

- Hospitalisation : Isolement
- O2 thérapie, Aérosol
- Si voie rauque : Adrénaline/SSI
- Si râles sibilants : Salbutamol/SSI
- ATB : Claforan + Zeclar
- Ration de base
- Si Hyponatrémie + GB > 30.000 : Maligne

→ Hospitalisation en Réanimation

Diphtérie

● Clinique:

- Angine diphtérique (Pseudo membraneuse)
- Fausses membranes:
 - Adhérentes (difficile à détacher)
 - Hémorragiques (si vous les détacher)
 - Envahissantes la luette
 - Confluentes
- Pâleur, abattement, asthénie, fièvre modérée, AEG, pâleur, tachycardie, ADP sous angulo-mandibulaire , nez très souvent infecté, coryza unilatérale..
- Cas similaire, absence ou retard de vaccination

Prélèvement de gorge sur les FM sur écouvillon sec (examen direct + culture)

✓ Traitement:

- Sérothérapie: $1000 \text{Ui} \times \text{poids}$
- Sérum AD=> Adulte: 80.000_100.000ui
- Enfant: 20.000_50.000ui
- Vaccination

■ ATB:

- Pénicilline G inj

Adulte: 100.000Ui/kg/j

Enfant: 50.000Ui/kg/j

Ou Erythromycine Adulte $3 \text{g/j } 2_3/\text{j}$

Enfant 50mg/kg/j

- Extencilline

>27kg: 1.2Mui en IM

<27kg: 600.000ui en IM

- Amoxicilline/8h

✓ Traitement symptomatique:

- Perfalgan/6h si fièvre
- CTC si détresse
- Déclaration obligatoire
- Éviction 30j



Fièvre boutonneuse FBM

● Clinique :

- Fièvre, myalgies, frissons, céphalées
- Tâche noire : cuir chevelu, aine, pli inter fessier

Non douloureuse, ADP indolore, conjonctivite, escarres multiples..

- Éruption respectant le visage

Maculeuses puis maculopapuleuses

- Bilan : 

- FNS : Leuco thrombopénie puis Hyperleucocytose à PNN

- VS ↗

- ASAT/ALAT/LDH ↗

- Sérologie de Weil et Félix

✓ **Traitement :**

- Doxycycline 200mg/j 1 ou 2_4/j
- Enfant <45kg : 5mg/kg dose unique
- <7ans ou grossesse : Josamycine !!
- Maligne : Doxycycline 200mg/j en IV 10j

Ou Phénicolés Ou Fluroquinolones



Leptospirose

● Clinique :

Leptospirose ictéro hémorragique

Ictère : flamboyant orangée, hépatomégalie

Syndrome : Infectieux, méningé, rénal,
hémorragique (hémorragie sous conjonctivale)

■ Bilan : 

■ FNS : Hyperleucocytose/Thrombopénie

■ Transaminases ↗

■ Bilirubine ↗ conjugué ++

■ Créat ↗

■ CPK LDL ↗

■ CU : protéinurie, leucocyturie, hématurie

■ PCR

✓ Traitement : ATB pdt 7_10j

■ Peu sévère : VO

Amoxicilline 1g 2/j

Ou Doxycycline 100mg 2/j

Ou Azithromycine 1g suivi de 500mg 1/j pdt 2j

■ Sévère : IV

Amoxicilline 1g 3/j

Ou Pénicilline G 1.5 Mui 4/j

Ou Ceftriaxone 1g/j

Ou Cefotaxime 1g/6h

Mononucléose infectieuse MNI

● Clinique :

- Fièvre, myalgies, céphalées, asthénie
- Angine érythémato pultacée ou fausses membranes
- ADP, splénomégalie, hépatomégalie
- Éruption cutanée érythémateuse polymorphe

■ Bilan :

■ FNS :

Hyperlymphocytose/Thrombopénie/Anémie hémolytique

■ Cytolyse hépatique

■ Sérologie MNI test

■ TG/LDH ↗

■ Transaminases ↗

■ Confirmation Sérologique : Sérologie EBV

✓ Traitement :

- Repos, pas d'éviction scolaire
 - Symptomatique=> Antipyrétique
 - ATB si surinfection
 - CTC si complication ou œdème pharyngé
- 1mg/kg/j pdt 10j puis ↘ progressive

Morsure d'un animal

✓ Traitement de la plaie :

■ Proscrire toute suture ou pansement

⇒ Points de rapprochement après installation du SAR si plaie hémorragique ou profonde.

■ Soins locaux :

Nettoyage de la profondeur à l'eau avec savon Marseille puis appliquer une solution à l'alcool iodée.

■ Si Morsure d'un rat pas VAR ni SAR

=> Doxycycline 1/j le soir pdt 5j

200mg :>60kg

100mg :<60kg

⊖ CI chez l'enfant <8ans et femme enceinte

Amoxicilline 50mg/kg/j pdt 5j

■ Adulte : Augmentin cp 1g 1cp 2/j

■ Enfant : Augmentin sirop 1ddp 2/j

Préventif pdt 5j si signes d'infection 10j

Si allergie aux bétalactamines=> Doxycycline

■ VAT si sujet adulte

1 Stade I : Rien

2 Stade II :

■ VAR => J1J2J3J4J5J6 en sc periombilical

Ou Verorab Tnder en J1J7J21 (J0 :2 doses/J7 : 1 dose/J21 : 1dose) en IM

Adulte et enfant >5ans=> 2cc

Enfant=> 1cc (1/2amp)

Puis les rappels en intradermique J11J15

Adulte et enfant >5ans=>0.25cc en 2 Points différentes

<5ans=>0.1cc

Rappels J30J90 en ID si grande lésion

Ou Adulte et enfant : muscle deltoïde

<2ans : antéro latéral de cuisse

3 Stade III :

VAR + SAR + VAT

● SAR : Dose= $(40 \times \text{poids}) / 200$

Un flacon => 5ml

Une quantité de la dose est infiltrée autour la plaie et le reste en IM après un test (0.1ml en sc 15min après 0.25ml en sc 15min après :

Si réaction (-)=> la totalité du reste en IM

Si réaction (+)=> 0.25ml chaque 15min jusqu'à l'épuisement de la dose.

Ou 5ui/kg Max 15ui

Poids/5 Max 15cc

● Schéma tissulaire : VAR

7 doses en périombilical

Puis rappels en ID au niveau de l'avant bras :

Grade II : J10 J14 J29 J90

Grade III : J10 J14 J24 J34 J90

● Schéma cellulaire : Rabipure Grade II et III

Essens : 2 doses en J0

Puis rappels en IM deltoïde : J3 J7 J14

Zagreb : 2 doses en J0

Puis rappels en IM deltoïde : J7 J21

(<2ans à la face antérolatérale de cuisse)

Morsure au niveau oculaire

- Lavage abondant au SSI
 - Sérothérapie : la quantité calculée
 - Rinçage de l'œil avec SAR dilué dans SSI 0.9%
- + Infiltration autour de l'œil en périorbitaire

Si reste : injecter en IM

- VAR +/- VDT

→ Avis ophtalmologie

1- Apprécier la nature de l'agression et ses caractères :

GRADE I	-contact direct avec un animal (la personne l'a touché ou nourri), - léchage de la peau intacte.
GRADE II	. morsure(s) ou griffure(s) sans saignement siégeant ailleurs qu'à la tête, aux extrémités et aux organes génitaux.
GRADE III	▪ morsure(s) ou griffure(s), même sans saignement, siégeant à la face, à la tête, au cou, aux mains, aux pieds aux organes génitaux, ▪ morsure ou griffure unique ou multiple avec saignement ou ayant traversé le derme ▪ morsure(s) par animal sauvage ▪ exposition à une chauve - souls (morsure ou griffure ou manipulation), ▪ léchage ou contamination des muqueuses par la salive, projection de bave sur les muqueuses en particulier les yeux ▪ léchage sur peau lésée.

Morsure du serpent

✓ CAT :

- Immobiliser et surélever le membre
 - Bandage non serré
 - Glace locale
 - SAV autour du plaie pour Grade 2 et 3
 - VAT, pas de CTC
-
- SAV :
 - Même dose quelque soit l'âge ou poids
 - Pas de CI : immunodépression, grossesse, allaitement, maladie chronique

 Hospitalisation : tout les grades

Traitement symptomatique

- Si pas de signes généraux :

- Augmentin 2g/j

- Désinfection locale

- Surveillance 24h

- Œdème + signes généraux :

- Prodaf 1g en IVL

- Augmentin 2g/j

- Gentamycine 80mg/j

- SAV 1 amp de 4ml diluée dans 100cc SSI 9%
passé sur 1h

- À répéter chaque 5h jusqu'à disparition des
signes

- Œdème + signes généraux + complications :

- Précédent + Héparine si CIVD

- Classification Algérienne :

- Grades 0_1 : Hospitalisation systématique, Bilan, surveillance 24h, sans sérothérapie

- Grades 2_3 : Hospitalisation systématique, Bilan, Sérothérapie AV

- Bilan

- FNS (Hyperleucocytose/Thrombopénie)

- Urée/Créat (IRA)

- Ionogramme (Hyperkalémie)

- GDS + Lactacidémie (Acidose métabolique)

- Hémostase (TP↘)

- Fibrinogène/DDIMÈRES/Complexes solubles (CIVD)

CONDUITE À TENIR DEVANT UN CAS DE MORSURE DE SERPENT

GRADE DE MORSURE	TABLEAU CLINIQUE	CONDUITE À TENIR
GRADE 0: MORSURE SANS ENVENIMATION (MORSURE BLANCHE)	- TRACES DE CROCHETS AU NIVEAU DE LA MORSURE - ABSENCE D' OEDEME OU DE REACTION LOCALE - EN GENERAL INDOLORE	- SURVEILLANCE DE 4 HEURES AUX URGENCES (APPARITION D'OEDEME) - AU- DELA, UNE EVOLUTION VERS GRADE I EST IMPROBABLE - DESINFECTION LOCALE ET CONTROLE DE LA VACCINATION ANTITETANIQUE
GRADE I: ENVENIMATION MINIME	- OEDEME LOCAL DOULEUREUX - ABSENCE DE SIGNES GENERAUX	- HOSPITALISATION PENDANT AU MOINS 24 HEURES AUX URGENCES. - REEVALUER LA GRADATION TOUTES LES HEURES PENDANT LA PERIODE D'AGGRAVATION MAXIMALE (6 PREMIERES HEURES) - TRACER LE NIVEAU DE L'OEDEME AU FEUTRE SUR LA PEAU. - EXAMENS BIOLOGIQUES A RENOUELER TOUTES LES 6 HEURES. - TRAITEMENT IDEM AU GRADE 0 ET ANTALGIQUES (EVITER LES SALICYLES).
GRADE II: ENVENIMATION MODEREE	- OEDEME REGIONAL DU MEMBRE ET/OU SYMPTOMES GENERAUX MODERES (HYPOTENSION MODEREE, MALAISE, VOMISSEMENT, DOULEURS ABDOMINALES, DIARRHEES)	- HOSPITALISATION EN REANIMATION. - SERUM ANTIVIPERIN DOIT ETRE ADMINISTRE LE PLUS TOT POSSIBLE, AU MIEUX DANS LES 6 HEURES. - ANTIBIOTHERAPIE DOIT ETRE ENVISAGEE S'IL EXISTE UNE INFECTION OU NECROSE LOCALE.
GRADE III: ENVENIMATION SEVERE	- OEDEME EXTENSIF ATTEIGNANT LE TRONC ET/OU SYMPTOMES GENERAUX SEVERES (HYPOTENSION PROLONGEE, CHOC, REACTION ANAPHYLACTOIDE, ATTEINTES VISCERALES).	- HOSPITALISATION EN REANIMATION. - SERUM ANTIVIPERIN (GRADE II) - CORRECTION RAPIDE DES TROUBLES HEMODYNAMIQUES : EXPANSION VOLEMIQUES, SYMPATHOMIMETIQUES. - TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DES COMPLICATIONS.

NB : Quel bilan effectuer ? à quel moment ?

FNS ; TP ; TCK ; Fibrinogène ; ionogramme sanguin ; urémie ; créatinémie ; CPK ; produits de dégradation de la fibrine

Dès l'apparition des signes d'envenimation locale.

REFERENCES : EMC URGENCES.

Morsure humaine

✓ CAT :

- Allonger le patient
 - Immobilisation du membre mordu
 - Enlever les bagues..
 - Bondage non serré
 - Glace locale
 - Désinfection locale
 - Injection de SAV autour la lésion
 - ATB : Augmentin
 - Si présence des signes généraux :
Gentamycine 80mg/j + Augmentin
 - SAV (sérum hétérologue mixte) : 4ml diluée
dans 100cc de SSI en 1h
- A renouveler chaque 5h si besoin
- Ou SAT

Oreillons

● Clinique :

- Maladie virale infantile très contagieuse, âge scolaire
- Gonflement en avant des oreilles d'un côté puis se bilatéraliser, mâcher et avaler devient douloureuses
- Tuméfaction + Douleur + Fièvre

✓ CAT : Traitement symptomatique

- Repos/compresses chaudes
- Isolement et éviction scolaire

⊖ CTC et AINS sont CI

1 Eludril sol >6ans 3/j pdt 8j

Ou Hextril 0.1% sol 3/j pdt 8j

2 Doliprane selon poids

- Si surinfection :

Zeclar cp/susp buv pdt 7j

1cp 2/j Si Adulte

1ddp 2/j Si Enfant

- Testicules : ↗Volume + Douleur + Fièvre

- Immobiliser la bourse

- Paracétamol

- ATB si surinfection

Piqûre d'araignée

✓ CAT :

- Nettoyage au savon doux
- Surélévation du membre
- Compresse froide pdt 10_15min pour ➤ l'inflammation et la douleur
- Surveillance 24h
- Antalgique
- ATB si surinfection
- AH ou CTC : HHC

Piqûre de Méduse

- Compresse chaude 20_30min

- 1 amp SAT en IM

- Perfalgan ou AINS

- ✓ Traitement de sortie :

- 1 Antihistaminique oral

- 2 Corticoïde locale

- 3 Fucidine pmd

- CTC inj si :

- Œdème important

- Urticaire généralisée

- Signes de choc anaphylactique

- Terrain allergique connu

- Échec du traitement (douleur persistante malgré lavage, antalgique, AH)

Piqûre de Mille pattes

- Lavage abondant au SSI ou à l'eau + savon
- Poche de glace
- Si présence des signes inflammatoires:
œdème, gonflement au point de piqûre=> CTC
en IM ou IV 1mg/kg
- Solumedrol 40mg en IM
- Si fourmillements: Mg
- O2 thérapie
- Surveillance
- VAT/SAT

Piqûre de Tique

✓ Traitement préventive :

- Doxycycline 100mg 2cp/j en monoprise pdt 10j
- Bilan infectieux

→ Orientation infectieuse si signes cliniques

Rongeurs

 Aucun risque Rabique

 CAT :

- ATB
 - Soins locaux
 - Vérification et correction du statut Vaccinal
- Antitétanique

Rougeole

● Clinique :

- Fièvre, AEG, catarrhe oculo laryngo nasal : larmoient, œil rouge, rhinorrhée, toux
- Signe de Koplick : petits points blanchâtres bleutés « en grain de semoule » sur fond érythémateux, inconstant et fugace au nv de muqueuse jugale.
- Éruption maculopapuleuses
- Xanthème morbiliforme débute derrière les oreilles avec intervalle de peau saine.
- Déclaration obligatoire
- Éviction 5j

✓ Traitement symptomatique :

- Antihistaminique
- Chlorhexidine/Eosine aqueuse 1 app 2/j
- Paracétamol

Rubéole

● Clinique :

- BEG, fièvre, courbatures, myalgies, arthralgies, rhinorrhée, toux, conjonctivite, ADP
 - Exanthèmes maculo papuleux, début au visage pas cuir chevelu, tronc, membres supérieurs puis inférieur, pas prurit
 - Respecte la région palmoplantaire
 - Exanthème maculopapuleux rose au niveau de la face puis thorax sans atteinte de cuir chevelu
-
- Bilan : 
 - FNS=> Leucopénie/Sd mononucléose :
Hyperlymphocytose
 - PCR
 - Sérologie

✓ Traitement :

- Repos
- Symptomatique : Antipyrétique
- Éviter le contact avec la femme enceinte 🚫

Sueurs nocturnes

● Signes associés : fièvre, amaigrissement, toux, tachycardie, asthénie, arthralgies, ADP..

- Bilan : 
- FNS=> Lymphomes
- TSH=> Hyperthyroïdie
- Glycémie à jeûne=> Hypoglycémie
- CRP/VS
- Urée/Créat
- Hépatique
- Lipidique

- Sérologie de Wright=> Brucellose
- IDR=> Tuberculose
- TLT
- ECG

Syphilis

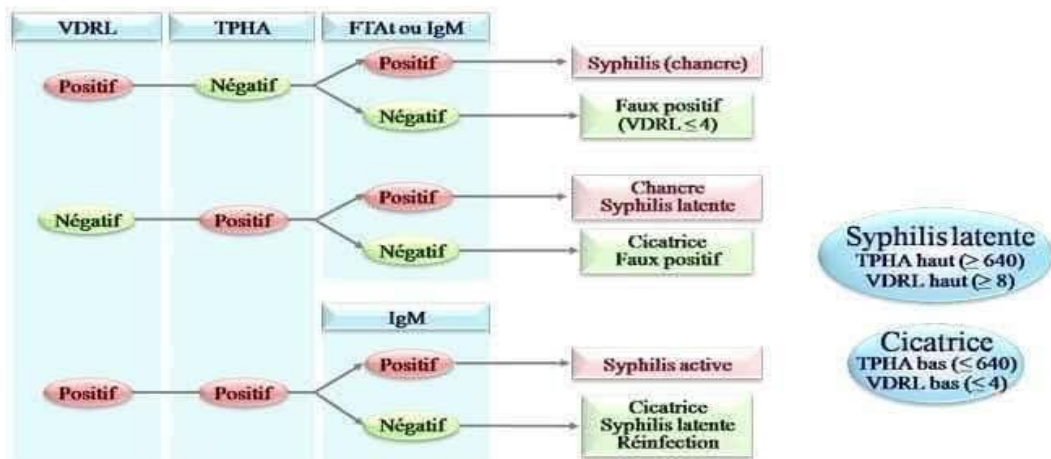
● Clinique :

- Syphilis primaire : chancre ou érosion indolore avec ADP inguinales ++
- Syphilis secondaire : manifestations cutanéomuqueuses (roséole, plaques muqueuses génitales ou buccales..)
- Syphilis latente : asymptomatique, la découverte est fortuite par sérologie
- Syphilis tertiaire : complications viscérales (cardiaques neurologiques osseuses)
- TPHA(+)/VDRL(-)=> Syphilis traitée
- Extencilline 2.4MU inj IM unique
3inj à 8j d'intervalle
- Contrôle : Clinique et biologique
3mois, 6mois, 1an puis chaque année jusqu'à
(-)

■ VDRL doit être (-) :

1an après traitement de Syphilis I

2an après traitement de Syphilis II



Tétanos

● Clinique :

- Infection non immunisante
- Trismus : contraction bilatérale symétrique des muscles de masséters, douloureuse sans fièvre
- Signe de l'abaisse langue captif
- Risque de fausse route : arrêt de l'alimentation orale
- Faciès sardonique, opisthotons (contracture des muscles para vertébraux), membres supérieurs en flexion et inférieurs en extension
- Dysphagie, spasme laryngé, apnée, cyanose, ventre en bois, crises tonico cloniques, rétention urinaire..

✓ Traitement :

- SAT : avant 72h une dose de 1ml/1500UI, soit Sc ou IM, peut être doublée ou triplée si blessures graves

Donc 1amp de 1500UI quelque soit l'âge ou poids, après un test intradermique

- Si plaie infectée profonde : 2amp : 3000UI

⚠ Jamais SAT seul, toujours + VDT

- Ou HRIG (humain) : 20×poids / ERIG : 40×poids

Dose max : 3000Ui

- Immunoglobulines

- ATB : Peni G 4_8MUI/j

- Si allergie : Tétracycline 200mg/j Ou Flagyl

- Traitement de porte d'entrée

- Vaccination

- PEC en Réanimation

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
 MINISTERE DE LA SANTE
 ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE PROXIMITE EL AMRIA
 SERVICE D'EPIDEMIOLOGIE ET DE MEDECINE PREVENTIVE

Conduite a tenir devant une plaie a risque tetanigene

Statut vaccinal	Nature du risque			
	Risque modere		Risque eleve	
	-plaies minimes -ulceres cutanes -intervention chirurgicale		-plaies larges s	
	DT	SAT	DT	SAT
<u>Sujet bien vaccine</u> Dernière dose de vaccin datant de moins de 05 ans	NON	NON	NON	NON
Dernière dose de vaccin entre 05 et 10 ans	NON	NON	01 RAPPEL DE VACCIN	NON
Dernière dose de vaccin datant de plus de 10ans	1 RAPPEL DE VACCIN	NON	1 RAPPEL DE VACCIN	OUI
Vaccination incomplète	1 dose de vaccin puis compléter la vaccination selon le calendrier vaccinal	NON	1 dose de vaccin puis compléter la vaccination selon le calendrier vaccinal	OUI
Sujet non vaccine ou vaccination incertaine	1 dose de vaccin puis compléter la vaccination selon le calendrier vaccinal	OUI	1 dose de vaccin puis compléter la vaccination selon le calendrier vaccinal	OUI

Toxoplasmose

- Femme enceinte Sérologie (-) :
- Laver les mains, fruits et légumes
- Viande très bien cuite
- Éviter les chats

Contrôle mensuel de la Sérologie :

- IgG(+) et IgM(-) : refaire 3sem après
- Si IgG taux stable : Infection ancienne
- Si IgG taux doublé : Infection récente avec IgM fugace
- IgG(-) et IgM(+) : séroconversion au tout début

Refaire 3sem après

Rovamycine !!

- IgG(+) et IgM(+) : Infection récente
- Avidité faible : récente
- Forte : ancienne
- Refaire 3sem après si IgG stable : ancienne
- Si récente => Rovamycine 9MUi/j

Tuberculose

● Clinique :

Fièvre prolongée vespérale, amaigrissement, sueurs nocturnes, toux chronique >3sem sèche puis productive, asthénie profonde, hémoptysie

■ Bilan : 

■ FNS

■ CRP

■ Procalcitonine

■ IDR à la tuberculine

■ TLT de face

■ ECB des crachats

■ Bacilloscopie des crachats de 3j

■ +/- TDM thoracique

Varicelle

● Clinique :

Maladie infectieuse virale extrêmement contagieuse. Elle est responsable d'une éruption de vésicules sur la peau et les muqueuses, touche le cuir chevelu

- Éviction scolaire 10j
- Bain + couper les angles.

⊖ CI dessous AINS

✓ Traitement :

- 1 Chlorhexidine/Eosine aqueuse 2app/j
- 2 Doliprane cp 500mg 3/j
- 3 Histagan cp 1cp/j la nuit pdt 5j Ou Xycare 5mg
- 4 Fucidine pmd

■ Pour les cicatrices: 2/j

■ Mederma

■ Mebo crème

■ Avene cicalfate

+ Écran total

■ Enfant 🧒 :

1 Chlorhexidine/Eosine aqueuse 1 app 2/j pdt 7j

2 Histagan sirop 1 cac 3/j pdt 5j

Ou Polaramine / Clarityne

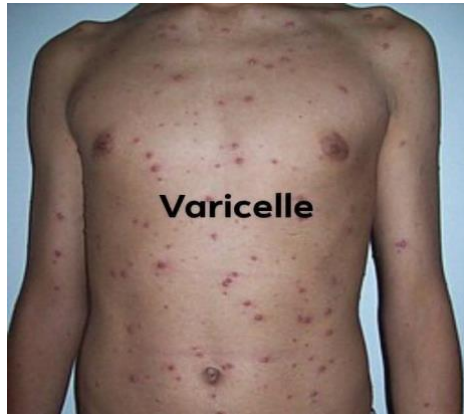
Airditine:

<25kg=>2.5ml

>25kg=>5ml

3 Paracétamol 60mg/kg/j 3/j

4 Fucidine pmd 1 app 2/j pdt 7j



Viroses

Rubéole/Rougeole/Varicelle

- 1 Histagan sirop 1cam 2/j
- 2 Chlorhexidine/Eosine aqueuse 1app 3/j
- 3 Paracétamol

■ Surinfection :

- 1 Keforal sirop 1ddp 3/j
- 2 Zeta crème 1app 2/j
- 3 Chlorhexidine/Eosine aqueuse 1app 3/j

Zona

● Clinique :

Éruption en bande vésiculeuse sous forme des croûtes après cicatrisation laissant des séquelles, unilatérale, douloureuse, démangeaisons,

+/_ fébrile, suit le trajet d'un nerf, ADP axillaires++

✓ Traitement :

■ Bilan : ⚕ Rénal avant et après le traitement à cause de la néphrotoxicité de l'Aciclovir

Pas Aciclovir si immunocompétent <50ans

■ Aciclovir avant 72h

■ Immunodéprimé : âge >50ans, diabétique.. ➡ Traitement avant 72h

■ Immunocompétent : Traitement symptomatique + Aciclovir pmd

1 Aciclovir cp 10mg/kg 200mg 4cp 4_5/j pdt 7j

2 Aciclovir pmd 1app 2/j 1tube

3 Chlorhexidine/Eosine aqueuse sol 3app/j

4 Dolyc cp 1g 1cp 3/j

5 Neurovit B1B6B12 cp 1cp 2/j pdt 1_3mois

1 Zovirax cp 200/400mg 1cp 2/j

2 Zovirax pmd 1app 4/j

3 Chlorhexidine/Eosine aqueuse

4 Antalgique

5 Neurovit

⚠ Éviter l'Eosine aqueuse, puisque la coloration peut masquer une surinfection..

■ Si surinfection :

1 Keforal cp 1g 1cp 3/j pdt 7j

⊖ Si sujet jeune=> rechercher une immunodépression

- Bilan :  ID
- FNS
- Glycémie à jeûn/HBA1C
- Rénal
- Hépatique
- Sérologie :
 - HCV
 - HAV
 - HBV
 - HIV
 - TPHA/VDRL

■ Enfant 🧒 :

1 Chlorhexidine/Eosine aqueuse

2 Deslor

3 Doliprane

+/_ Aciclovir gel 1 app 2/j matin et nuit

